

Fecha Última Actualización: 27-12-2022 12:33:20

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Pedro Nolasco Herrera Valenzuela **Rut** : 7.288.826-K **N° Archivo** : A639515
Edad : 72a 3m 22d **Fecha Nacto**: 05/09/1950 **Sexo** : Masculino
Dirección : Orilla Del Rio 167 Parcela 9, El Principal **Comuna** : Pirque **Teléfono** : 9 8658 7255

N° Epicrisis
331619

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Ingreso** : 15/11/2022 12:34 **Días Estadía**: 42
Unidad de Egreso : Utim (5to Piso Mater) **Fecha Egreso** : 27/12/2022 12:12

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

dolor abdominal

Comorbilidades

Diabetes Mellitus 2; Insuficiencia Renal Crónica; Enfermedad Arterial Oclusiva Periferica;

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Pedro Nolasco Herrera Valenzuela
Edad: 72 años
RUT: 7.288.826-K
FI UCI: 15/11/22
FI UTIM: 23/11/22
FRI UCI: 27/11/22
Contacto: + 56 9 68120324

ANTECEDENTES:

Antecedentes médicos:

- Diabetes mellitus 2 insulino-requiere con daño de órgano blanco (retinopatía diabética no proliferante leve/moderada, neuropatía diabética, nefropatía diabética, enfermedad arterial oclusiva, pie diabético)
- Enfermedad renal crónica etapa IIIB (nefropatía diabética)
- Enfermedad arterial oclusiva con pie diabético operado con amputación del trans metatarsiana derecha y stent biliaco y bypass fémoro-popliteo derecho 2018
- Dislipidemia mixta

Antecedentes quirúrgicos: Amputación del ante pie derecho, Bypass ileofemoral

Medicamentos: Losartán, Amlodipino, Metformina, Glibenclamida, Aspirina, Insulina 18 UI AM - Amitriptilina

Alergias: No

Hábitos: TBQ (+ suspendido), OH (social), drogas (THC)

Hospitalizaciones recientes: No

HISTORIA DE INGRESO:

Paciente con antecedentes descritos. Consulta por cuadro de 2 semanas de dolor abdominal tipo cólico y disnea progresiva.

Laboratorio destaca: K 8.33, pH 7.038, pCO2 24.6, HCO3 6.5, Hb 9.0, GB 20560, RAN 19200, RAL 700, plaq 504000, BUN 186.2, crea 11.67, lipasa 1100, Ca 11.2, TpUS 2440, PCR 260.

PCR COVID (-)

Se realizó un TAC de tórax que mostró signos compatibles con neumonía COVID.

Además un angio TAC AP que mostró extensa enfermedad aterosclerótica, signos de endoleak protésico iliaco, estenosis de ambas arterias renal en 70 - 90%. Estenosis de ambas arterias mesentéricas sin signos de hipoperfusión intestinal.

Fecha Epicrisis : 27/12/2022 12:33

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 27-12-2022 12:33:20

Página 2 de 2

Conexión a CNAF con mala respuesta, se intuba el 15/11 y se inicia BNM.
Se traslada a UCI para continuar manejo.

DIAGNÓSTICOS DE INGRESO:

1. Sepsis de foco pulmonar
- Neumonía Multifocal. COVID imagenológico PCR (-)
2. Insuficiencia renal aguda
3. Anemia severa transfundida
3. Infarto tipo 2
4. Estenosis focal proximal 70 y 90% de ambas arterias renales principales

EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN:

Durante estadía, requiere dos ciclos de ventilación mecánica invasiva (inicialmente por sospecha de neumonía Covid-19 con patrón típico al TAC pero PCR negativa, y luego por neumonía multifocal por S. maltophilia). Mantiene insuficiencia respiratoria persistente que se atribuyó a interurrencias infecciosas e insuficiencia cardíaca descompensada. Difícil manejo de volúmenes por volumen mal distribuido. Además cursó con falla renal que requirió diálisis y ultrafiltración en múltiples ocasiones.

En las últimas 2 semanas, presentó mayor deterioro ventilatorio y de función renal. Se inició manejo con drogas vasoactivas, inótrópos, diuréticos y ultrafiltración. Además se escaló en antibióticos por cultivo de aspirado traqueal (+) para microorganismo multirresistente (ACBA resistente a carbapenémicos, en manejo ajustado con colistin). Soporte ventilatorio con ventilación mecánica no invasiva.

Se define que paciente se encuentra en techo terapéutico, familiares al tanto. Tras 7 días de terapia, mantiene escasa respuesta clínica.

Finalmente, paciente fallece el 27/12/22 a las 12:00 hrs.

Diagnóstico de Egreso

Covid-19, Virus No Identificado -
Sepsis, no especificada - Foco Respiratorio
Traqueobronquitis Por Acba R Carbapenemicos -
Insuficiencia Renal Aguda Sobre Crónica - En Trr Por Obs Enfermedad Renovascular
Insuficiencia respiratoria aguda -

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallece

Plan Post Alta

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Victoria Polanco Trampe
Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 27/12/2022 12:33

Página 2 de 2

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:19

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar